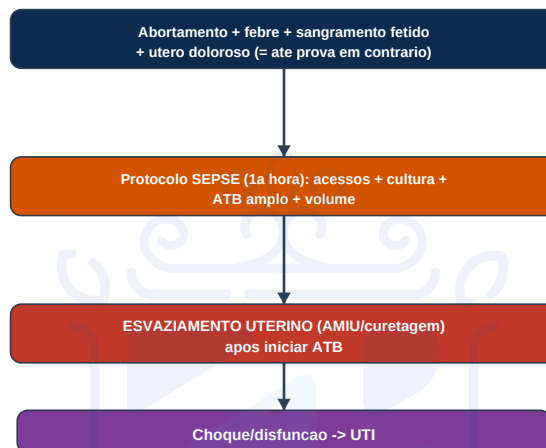


ABORTO INFECTADO — ATB + ESVAZIAMENTO

FLUXOGRAMA — EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA

ABORTO INFECTADO — SEPSE + ESVAZIAR



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Infecção uterina associada a aborto (espontâneo ou provocado), geralmente POLIMICROBIANA
- Alto risco de sepse e choque séptico
- Germes: gram-negativos (E. coli), anaeróbios (Bacteroides, Clostridium), Streptococcus, Staphylococcus
- ABORTAMENTO + FEBRE = aborto infectado até prova em contrário

QUADRO CLÍNICO

QUANDO SUSPEITAR

- Febre $\geq 38^{\circ}\text{C}$; dor abdominal/pélvica
- Sangramento vaginal FÉTIDO; útero doloroso à palpação
- Taquicardia, hipotensão; calafrios, mal-estar
- Sinais de sepse / choque séptico
- Investigar manipulação/aborto provocado (risco de Clostridium e perfuração)

ABORDAGEM INICIAL — PRIMEIRA HORA (PROTOCOLO SEPSE)

Rx

NÃO ATRASAR O ANTIBIÓTICO

ABCDE; O₂ se SatO₂ < 94%; monitorização; 2 acessos calibrosos; SVD (diurese); elevar MMII se choque

Exames (sem atrasar ATB): hemograma, beta-hCG, LACTATO, creatinina/ureia, TGO/TGP, coagulograma, gasometria se grave

HEMOCULTURAS (2 pares) + tipagem e prova cruzada; USG pélvico se disponível

Volume: cristalóide 30 mL/kg se hipotensão ou lactato ≥ 4

Vasopressor: noradrenalina se PAM < 65 após volume

ANTIBIOTICOTERAPIA + CONTROLE DO FOCO

Rx ATB EM ATÉ 1h + ESVAZIAR

ESQUEMA PADRÃO: Clindamicina 900 mg IV 8/8h + Gentamicina 5-7 mg/kg IV 1x/dia (cobrir anaeróbios, Gram + e Gram -)

Alternativas (sepse grave/choque): Ampicilina + Gentamicina + Metronidazol; Piperacilina; Meropenem (grave/resistência)

ESVAZIAMENTO UTERINO (essencial) APÓS iniciar o ATB: AMIU ou curetagem

Não retardar o esvaziamento na instabilidade materna

ANTIBIÓTICO ISOLADO NÃO RESOLVE — o foco (conteúdo uterino) precisa ser removido

Duração do ATB: IV até afebril 24-48h e estável; completar 7-10 dias (IV + VO)

INTERNAÇÃO EM UTI E COMPLICAÇÕES

GRAVIDADE

- UTI se: choque séptico, necessidade de vasopressor, disfunção orgânica, rebaixamento de consciência
- Complicações: choque séptico, CIVD, insuficiência renal aguda, perfuração uterina, óbito materno
- Aborto por Clostridium: gangrena/miosite uterina — pode exigir histerectomia
- Avaliação cirúrgica precoce se perfuração/abscesso/falha de controle do foco
- Mensagem-chave: ATB precoce + esvaziamento uterino salvam vidas

CHECKLIST NO PS

NÃO ESQUECER

- ☐ Reconhecer abortamento + febre como aborto infectado
- ☐ Pacote de sepsis na 1ª hora (acessos, culturas, lactato, ATB amplo, volume)
- ☐ ATB empírico (clinda + genta) em até 1h
- ☐ Esvaziamento uterino após iniciar ATB (não adiar na instabilidade)
- ☐ UTI se disfunção orgânica/choque; imunoglobulina anti-D se Rh negativo

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Aborto infectado (___ semanas); febre ___, sangramento fétido, útero doloroso; lactato ___.
- Pacote de sepsis iniciado: acessos, hemoculturas, ATB (clinda+genta) às ___, volume ___.
- Esvaziamento uterino: realizado/pendente; vasopressor: sim/não.
- Solicito vaga (UTI se choque) e equipe obstétrica para esvaziamento/controle do foco.

Suporte do Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com aborto incompleto, febre 38,5, secreção vaginal fétida e útero doloroso. Além do antibiótico, qual medida é ESSENCIAL?

- A) Apenas antibiótico endovenoso
- B) Esvaziamento uterino (AMIU/curetagem) após iniciar o antibiótico
- C) Antitérmico e alta
- D) Observação por 48h sem intervenção
- E) Histerectomia de rotina

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o esquema antibiótico empírico padrão no aborto infectado?

- A) Amoxicilina oral isolada
- B) Clindamicina + Gentamicina (cobertura para anaeróbios, Gram + e Gram -)
- C) Azitromicina dose única
- D) Cefalexina oral
- E) Apenas metronidazol

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que o antibiótico isolado não resolve o aborto infectado?

- A) Porque os germes são sempre resistentes
- B) Porque o foco infeccioso (conteúdo uterino retido) precisa ser removido (esvaziamento)
- C) Porque o antibiótico não penetra no útero
- D) Porque a febre é viral
- E) Porque não há foco infeccioso

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual conduta da primeira hora NÃO deve ser atrasada no aborto infectado com sepse?

- A) Aguardar o resultado das hemoculturas para iniciar o antibiótico
- B) Iniciar antibiótico de amplo espectro em até 1 hora (após coletar culturas, sem atrasar)
- C) Realizar tomografia antes de tudo
- D) Transfundir plaquetas
- E) Iniciar corticoide

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual complicação grave está associada ao aborto infectado por Clostridium?

- A) Cefaleia tensional
- B) Sepse/choque com possível necessidade de histerectomia (miosite/gangrena uterina) e CIVD
- C) Anemia ferropriva leve
- D) Hipotireoidismo
- E) Rinite alérgica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O aborto infectado exige antibiótico amplo precoce E esvaziamento uterino (AMIU/curetagem) após iniciar o ATB — o controle do foco (conteúdo uterino) é essencial; antibiótico isolado não resolve.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O esquema padrão é Clindamicina 900 mg IV 8/8h + Gentamicina 5-7 mg/kg/dia, com excelente cobertura para anaeróbios, Gram-positivos e Gram-negativos. Pipe-tazo/meropenem nas formas graves.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O antibiótico isolado não resolve porque o foco (restos ovulares/conteúdo uterino infectado) precisa ser removido. O esvaziamento uterino é parte indissociável do tratamento.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

No pacote de sepse, o antibiótico de amplo espectro deve ser iniciado em até 1 hora (após coletar culturas, sem atrasar). Não se aguarda o resultado das culturas para iniciar.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O aborto por Clostridium pode causar miosite/gangrena uterina, sepse/choque grave e CIVD, podendo exigir histerectomia — quadro de altíssima mortalidade.

SM24
Suporte ao Plantão Médico